

Maakondlikud arenduskeskused analüüsisid hoolekandeteenuste arendamise võimalusi



Anneli Rasu

projektijuht, Läänemaa Arenduskeskus

Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel (meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”) kaardistasid arenduskeskused hoolekandeteenuste osutamise hetkeolukorda ja töid analüüsisid maakonniti välja sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vajadused aastaiks 2016–2020. Määratleti ka teenuste pakkumiseks omavalitsuse piiridest suuremad koostööpiirkonnad, sest see on taotlusvoorude avamise eeltingimus.

Maakondlikud arenduskeskused tegutsevad kõigis maakondades, pakkudes tasuta

nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja kohalikele omavalitsustele. Saaremaa Arenduskeskus ja SA Tuuru Hiiumaal olid hoolekandeteenuste arendamisega varem juba kokku puutunud, nad olid omavalitsuste partnerid eakatele mõeldud virtuaalsete hoolekandeteenuste rahvusvahelises arendusprojektis. Teised arenduskeskused pidid end analüüsi koostamiseks sotsiaalvaldkonna terminoloogiaga kärmelt kurssi viima – eks elukestev õpe ongi see, mis aitab nüüdses infoühiskonnas toime tulla.

Hoolekandeteenuste kaardistus

Maakondade kaupa koostatud hoolekandeteenuste kaardistused (2015. aasta lõpu seisuga) kirjeldavad teenuseid saavate ja vajavate sihtrühmade suurust ja teenuste kättesaadavust; omavalitsuste teenuste pakumise praktikaid: seda, kuidas omavalitsused teenusvajadust hindavad, teenuste kvaliteeti arendavad, teenuste osutamist delegeerivad ja teenuseid omavahel integreerivad. Kirja pandi ka rahastamisallikad ja arenduskavatsused, omavalitsusjuhtide, sotsiaaltöötajate, partnerorganisatsioonide ja sihtrühmade tõstatatud probleemid.

Andmeid kogudes kohtusid arenduskeskuste esindajad omavalitsuste sotsiaaltöö juhtidega ja väiksemates omavalitsustes ka sotsiaaltöötajatega. Selgus, et väikestes valdades ei olegi ehk võimalik teenuseid arendada, sest üks sotsiaaltöötaja osutab seal kõiki „teenuseid” tulekahju kustutamise põhimõttel. Väga ajamahukas teenus on sealjuures sotsiaaltransport: külates on elanikke järjest vähem, ühissõidukitega ei saa külast liikuma, kuid eriarstiabi on koondunud paari suuremasse linna. Sotsiaaltransporditeenust osutatakse sellises olukorras ka nii, et abivajaja sokutatakse näiteks vallavanema auto peale, kui see linna sõidab.

Sihtrühmi kaardistades selgus, et üsna täpselt on teada teenuse saajate arv, kuid abivajajate tegelikku arvu ei teatagi, kuna ressursinappuses omavalitsused ei korralda süstemaatilisi teenusvajaduse uuringuid. Näiteks omastehooldajate arvu on seni väga keeruline tuvastada, kuni pole isegi omastehooldaja definitsiooni. Väga laialt määratledes võib pea iga inimene olla mingil perioodil omastehooldaja, sest kõigi pere liikmed võivad ju abi vajada. Oluline on aga see, kuivõrd hoolduskoormus takistab tööealisel inimesel ennast ja oma perekonda ülal pidada. Äärmuslikult koormavate hooldussituatsioonide lahendamine nõuab riigi

suuremat panust. Perelele saavad kohalike omavalitsuste pakutavad hoolekandeteenused toetust pakkuda eeldusel, et teenuskordades on sihtrühmad vastavalt kirjeldatud. (Praegu kehtiv perekonnaseadus ja isegi põhiseadus seavad hoolduskohustuse just pereliikmetele.) Teisalt ei ole elanikud kuigi hästi kursis teenustega, mida võiks kohalikult omavalitsuselt saada. Nii ei jõua omavalitsuseni ka info abivajadusest.

Peamiselt rahastatakse hoolekandeteenuseid kohalike omavalitsuste eelarvest, sh keskvalitsuse sihtotstarbelistest eraldistest (toetusfond). Vaid üldhoolekandeteenuse (hooldus hooldekodus) eest maksavad kliendid ise või nende pereliikmed. KOV rahastab seda teenust vaid juhul, kui kliendil ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.

Vaesus pärsib teenuste arengut

Klientide maksevõime analüüs tõi välja, et nad ei suuda tihti teenuste eest tasuda. Näiteks Lääne maakonnas oli nii vanadus- kui ka töövõimetuspensionäride keskmine pension 317 eurot kuus. Eesti Statistikaameti andmetel elasid juba 2013. aastal suhtelises vaesuses need, kelle ekvivalentnetosissetulek oli alla 358 euro tarbija kohta kuus. Absoluutse vaesuse piir oli aga 205 eurot tarbija kohta kuus. (Laes 2015)

Samas oli 2015. aastal määratud üksi elavale inimesele või perekonna esimese liikme toimetuleku piiriks 90 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir oli 2015. aastal 90 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir oli 72 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir oli esimese täiskasvanud pereliikme puhul 2015. aastal 329 eurot; iga järgneva vähemalt 14aastase liikme puhul oli see 164,5 eurot ja alla 14aastase pereliikme puhul 98,7 eurot. Seega oli toimetulekupiir ligi poole võrra väiksem kui

on absoluutse vaesuse piir. Ka vajaduspõhise peretoetuse korral jäid alla 14aastaste lastega perede sissetulekud summaarselt absoluutse vaesuspiiri lähedale.

Kuigi teenuste pakkumiseks ja arendamiseks suunatakse läbi toetusfondi KOVi eelarvesse sihtotstarbelist raha, ei ole seda piisavalt. Sotsiaalministeerium on väljendatud mõistmatust, et miks seda raha lõpuni ära ei kasutata. Kui ei kasutata, pole ju juurde vaja. Sotsiaalvaldkonna arenguvõimalusi ei näita vaid rahanumber kohaliku omavalitsuse eelarve real. Seda mõjutavad veel järgmised asjaolud:

- 1) kas seaduses on selgelt kirjeldatud kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste sisu ja miinimumnõuded (uus sotsiaalhoolekande seadus jõustus 01.01.2016)
- 2) kas sihtrühm teab, milliste teenuste osutamine on seadusega määratud KOVi kohustus; kas sihtrühmal on piisavalt söakust, et neid teenuseid küsida
- 3) kui palju on sotsiaaltöö juhtidel missiooni-tunnet, energiat ja aega arendustegevuste eestvedamiseks, milline on nende läbirääkimis- ja suhtlusoskus nii volikogudes kui ka töötajatega
- 4) teenuste rahastusmudelid (kuna sihtrühma sissetulek on enamasti väike, siis paljudel juhtudel ei ole kliendi omaosalus võimalik)
- 5) volikogude prioriteetidid piiratud rahalistes tingimustes.

Maakondlikud analüüsid kajastavad eelkõige maakondades kokkulepitud arendustegevusi, sihtrühmade kirjeldusi, toime- ja teenuspiirkondi, teenuste rahastusvõimalusi, koostöömudeleid, partnereid, koostööprotsesside kirjeldusi ja arendustegevuste riske ning riskimaandamise võimalusi.

Maakondlike analüüside kõrval on koostatud kokkuvõte, mis toob välja igas punktis kõige olulisema, üldistus ei puuduta vaid koostööpartnereid, sest need on kõikjal erinevad.

Valgamaa soovib hõbemajanduse kompetentsikeskust

Maakonnas on mitmeid hoolekandeaustusi, kõik suuremad teenuseosutajad tegutsevad ärisektoris. Nende kogemusi ja kompetentsi soovimegi nüüd siduda sotsiaalhoolduse kutseõppega Valgamaa Kutseõppekeskuses. Kutsekeskuse juurde loodav hõbemajanduse kompetentsikeskus keskenduks uute nutikate tööprotsesside, infotehnoloogiliste ja keskkonna lahenduste väljatöötamisele hoolekandeteenuste jaoks. Keskuse abil võiks jõuda hoolekandeaustuste võrgustumise ja spetsialiseerumiseni, et teenuseid paremini turundada ja välja pakkuda võimalusi nt dementsusega eakate hoolduseks.

Uued lahendused peaksid leevendama ka hoolekandes töötavate inimeste väikeseid palku. 60–70% hoolekandeaustuste kuludest moodustavad palgad ja tööjõumaksud. See teeb teenuse ühelt poolt kalliks, teisalt ei võimalda teenusesaajate hinnatundlikkust hinda tõsta. Omavalitsuste riigipoolne rahastusmudel ei lase hoolekandesse ka palju rohkem raha panna. Kompetentsikeskuses loodavad lahendused võiksid aidata planeerida eaka ja puudega inimese kodust elukeskkonda ja linnaruumi nii, et see oleks ka erivajadustega inimestele ligipääsetav. Teave selle kohta, milline peaks olema erivajadusi arvestava kodu, korrusmaja ja avaliku ruumi terviklahendus, tuleb teha kõigile kättesaadavaks. Praegu on olemas üksikud lahendused, kuid universaalse disaini põhimõtteid ei ole praktikas eriti rakendatud.

Kompetentsikeskuse ideed on algatusrühm arendanud juba üle aasta ning peagi esitatakse oma taotlus kompetentsikeskuste programmi.

Meeli Tuubel

Valga Linnavalitsuse
sotsiaalabi ameti juhataja

Kui 2015. aasta septembris ei olnud määratletud veel ühtegi koostööpiirkonda, siis kaardistamise ja analüüside koostamise ajal korraldasid maakondlikud arenduskeskused hulgaliselt koostööseminare, mis töid partneritena kokku nii KOVid kui ka teenusepakkujad ja sihtrühmade esindusorganisatsioonid.

Väga palju sõltub sotsiaaltranspordist

Maakondade koondanalüüs toob välja, et ülejäänud teenused olenevad suuresti KOVi korraldatava sotsiaaltranspordi kättesaadavusest. Probleem on järjest teravam seoses ühissõidukite võrgu taandarengu ja eriarstiabi koondumisega suurlinnadesse. Seepärast keskendusid mõned maakonnad just ühissõidukiteenuse arenduskavatsuste läbimõtlemisele. Teistes maakondades jäi aga peale seisukoht, et ei ole mõtet hakata ise jalgratast leiutama, sotsiaalministeeriumile esitati soov, et probleemile leitaks lahendus riiklikul tasandil.

Lisaks sotsiaaltranspordile soovitakse kõige rohkem arendada **tugiisiku** teenust. Selle teenuse vajadus on väga suur, samas on teenuse pakkumisega seotud hulk probleeme (väike tasu, killustatud tööaeg, vähene koormus) ning tugiisikuid ei jätku. Lahenduseks on tehtud ettepanek nii sihtrühma suurendamiseks tugiisiku töomahu täitmiseks kui ka seda, et tugiisik võiks pakkuda teisigi teenuseid. Paljud maakonnad pidasid võimalikuks tugiisikute ja **isiklike abistajate** teenuse integreerimist. Isikliku abistaja teenuse eraldi arendamiseks ühtegi kavandit ei tehtud.

Intervallhooldusteenuste arendamist on peetud peamiseks võimaluseks, millega saaks vähendada omastehooldajate koormust. Arvestades teenuse suurt ressursivajadust, jääb küsitavaks selle jätkusuutlikkus pärast arendusprojekti lõppemist. Ajutise üldhooldusteenusena tundub see omastehooldajatele küll väga vajalikuna, kuid tegelikult osutatakse intervallhooldust harva. Seda kahel põhjusel.

Võrumaa teeb ettevalmistusi sotsiaaltranspordi arendamiseks

Seda, et omavalitsuste korraldatavatest sotsiaalteenustest vajab kõige rohkem arendamist sotsiaaltransport, leiti ka Võrumaa hetkeolukorra kaardituse ja ühiste arendusseminaride käigus.

Moodustasime teenuste arendusplaanide koostamiseks laiapõhjalise tööühma, mis koostas võimaliku mudeli, kuidas maakonnas sotsiaaltranspordi arendada. Kuna nõudlus sotsiaaltranspordi järele suureneb, oli meie esimene küsimus: kuidas saada sama rahaga rohkem teenust, kuidas teenuse korraldust optimeerida ja samal ajal hoida kvaliteeti? Lihtsam on optimeerida siis, kui teenuse maht on suurem ja seetõttu otsisime lahendusi maakonna tasemel. Võrumaal elab umbes 34 500 inimest, teenusevajajaid on üle 300.

Esmalt tuleb ühiselt kokku leppida teenuse definitsioonis – kas see on meie jaoks laiem, kui seadusest tulenevad miinimumnõuded. Võib-olla on vaja eristada sotsiaaltranspordi ja kogukonna transpordi teenused? Sõitude trajektooriga ja eesmärgist lähtudes eristub kolm teenuse kategooriat: vallasisesed sõidud, sõidud maakonna keskusesse ja maakonnavälised sõidud. Iga kategooria puhul on teenusel mõnevõrra erinev eesmärk ja seetõttu ka erinevad tehnilised lahendused. Kõik tasandid peavad toimima tervikliku süsteemina. Suurendada tuleb klientide arvu ühe sõidu kohta ja vähendada sõitude koguarvu ehk siis rohkem tuleb kasutada regulaarsõite. Ressursikasutus oleks tõhusam, kui leida teenust osutama sobivaim tööjõud, parandada sõiduvahendite riskasutust ja logistikat, et ei tekiks tühisõite. Läbi tuleb mõelda hinnapõhimõtteid ja juurutada ka täismahus tasulisi teenuseid. Teenuse korraldamise tuleb kindlasti kaasata kodanikud, see aitaks leida võimalusi kogukondliku kapitali kasutamiseks.

Kadri Kangro

Võrumaa Arenguagentuuri
sotsiaalvaldkonna projektijuht

1. Ajutisi üldhooldusteenuseid pakutakse kas üldhooldekodu või haigla juures, vastava päevamaksumusega. Kliendi jaoks lisandub üldhooldusteenuse (päeva)hinnale ka transpordi- ja ajakulu.
2. Üldhooldekodud on enamasti isemajandavad ja huvitatud kohtade täitmisest pikaajaliste klientidega. Hooldekodukohtade järele on suur nõudlus, hooldekodu ei saa mõistlikult majandada, hoides ootel ruume ja tööjõudu, et pakkuda seal ka ajutist teenust.

Kuidas jätkatakse teenuste arendamisega?

Koduteenuste edasiarendamine on äärmiselt oluline, sest see aitaks säilitada eakate ja erivajadustega inimeste paremat elukvaliteeti, vähendaks omastehooldajate koormust ning laseks edasi lükata nii peredele kui ka KOVile kuluka hooldekoduteenuse kasutamise. Koduteenustele võiksid kõige enam toeks olla uudsed **häirenupu- ja telehooldusteenused**.

KOVide koostöö otstarbekamaid mudeleid kirjeldades selgus, et mõnes maakonnas ei leidugi arendus- ja koostöö eestvedajaid. Kardetakse (rahalist) vastutust, pädevatel isikutel pole arendustöö jaoks aega. Koostöö erinevad võimalused ja protsessikirjeldus on nüüd välja pakutud. Võimalik, et arendustegevuste koordinaatorid tuleb palgata avatud taotlusvoorude abil.

Riskid võiks naljatamisi kokku võtta ka nii: põhiline probleem on see, et raha ei ole. Riigil pole raha pensionide ja toetuste maksmiseks, seetõttu pole klientidel raha, et tasuda teenuste eest. Kohalikel omavalitsustel ei ole raha, et palgata teenuseid arendavaid ja pakkuvaid töötajaid. Või kui raha ka on, siis pole volikogu nõus seda sotsiaalvaldkonnale kulutama, sest teenustele tuleb ju peale maksta, ja mingit tulu sellest justkui ei ole.

Toetus tööturul osalemiseks

Sotsiaalministeerium koostas paralleelselt kaardistuse ja analüüsiga meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” avatud taotlusvooru jaoks määrust. Kogutud materjali kasutati määruse sisendina. Esimeses avatud voorus saab taotleda toetust tugiisiku, isikliku abistaja, koduteenuste, päevahoiu ja intervallhoolduse arendamiseks.

Sellest toetusest võiks kasu olla tööealistel ja töötada soovivatel erivajadustega inimestel ning omastehooldajatel. Sotsiaaltranspordi arendusi esimesest voorust ei toetata, küll aga saab meetme rahast katta arendatavate teenustega seotud transpordikulusid.

Ministeerium töötab välja ühtset mudelit sotsiaaltranspordi teenuse korraldamiseks, kuid kohustus teenust pakkuda ja arendada jääb siiski omavalitsuste vastutusvaldkonda.

Avatud taotlusvoorude arendusprojektidele pannakse suuri lootusi. Sotsiaaltöötajad leidsid, et volikogudes on teenuse vajadust lihtsam põhjendada, kui teenuseid on abirahade toel katsetatud ning on selgunud, et teenust on tõesti vaja, kuna sellel on piisav tarbijaskond.

Kaardistuse ja analüüsi koostamisest on kasu, sest selle protsessi tulemusel on sõlmitud piirkondlikud kokkulepped teenuste arendamiseks ja asjaosalised soovivad kavandatud arendustegevused ellu viia. Läbi viidud kaardistamise ning analüüsi protsess tõestasid ennast kui olulist arendustegevuste ideede leidmise, sõelumise ning kavandamise instrumenti ning seda võiks aeg-ajalt korrata.

Kui õnnestub tagada kavandatud teenuste pakkumine enam-vähem samas mahu ka pärast 24kuulist käivitamisperioodi, siis tugevneb ka omavalitsuste koostööusk sotsiaalteenuste arendamisel ning motivatsioon jätkata sellega tulevikuski. **S**

Viidatud allikad

Laes, T.-L. (2015). Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus. Eesti Statistika Aastaraamat 2015.
<http://www.stat.ee/90732> (19.04.2016). 111–124.